

医中一得

顾
仪
卿

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

《医中一得》提要

《医中一得》序

医中一得

3

5

6

7

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

《医中一得》提要

夫医之为道，贵手实验。裘君吉生藏书至数千种，不以大部凑集众说之书为重，恒调单本小册之著作在往出自心得，多有发明之处，如外科王洪绪《全生集》、内症王清任《医林改增》等，立论不多，要皆独具创见，尤以所载方法无不历经试验，遂有不屈不挠之学说垂示于人。此书系顾仪卿先生所著，为裘君假录于同社曹炳章君。亦因其所论皆属心得，刊以裨益医林也。

《医中一得》序

诗曰：我思古人，实获我心。获之为言，得也，有得于心也。圣人之于学也，未得则发愤而忘食，已得则乐之而忘忧。学贵乎有得也如是。医之为道，亦何独不然。奥稽古圣上自轩岐中及仲景为医中之圣，圣则得之全也。厥后刘河间、李东垣、朱丹溪辈各执一见，各成一家。亦各有所得而为之也。迄今如叶香岩之批刻陶氏《全生集》，徐灵胎又评点《叶氏方案》，孰非有得于心而为之欤？余虽业医半生，碌碌于医道，茫无所得。每念前人，不胜惶愧，乃无何而仪卿宗台来，手执其所著《医中一得》示余，余受而读之，其中瘕疟一说发前人之所未发，葛升一方制前人之所未制。至如产后房劳与蓐劳异，既有明辨，又有定方，余以之治人，无不应手，知仪乡先生固有得于心而为之也。一得之所以名书也，原世之阅是书者，勿以管见视之。以之行世，参以己见，旁推类及，或者更有所得，并不止一得，何莫非是书之有所裨益而垂之不替耶？是为序。

癸亥仲春月，梁溪七世家医雅亭氏顾尔元拜撰，时年七十有四

医中一得

瘧症浅说

时交夏至以后，连日身体发热，午后更甚，至夜半出汗稍和，明日午后仍复大热，心胸懊侬，舌胎黄腻，脉数而洪，或有上午即大热者，或有大热前手足厥冷而热者，人皆称为瘧症。方中无不用表里双解，以伤寒之法治之。其感邪极轻者，虽不药亦愈。如稍重者，屡投无效。藉云：瘧症本难速愈，必延至月余，元气津液大伤，热仍不解。一病愈淹，无从措手，殊不知伤暑与伤寒病本不同，治亦各异。叶氏云：暑为无形之气，先从口鼻而入，法当轻扬解散。此语深得治此症之法。切思暑气入鼻，必先犯肺，入口必先犯胃。然肺胃热邪清之散之，似可易愈，何以治之无效？盖肺与脾为子母清与脾为表里，故肺胃之病最易及脾。午后更剧者，阳明之见端也。辰刻亦属阳明，巳属太阴，每日如是者，脾主信也。胃为腑，脾为脏，其病缠绵不已者，在腑易愈，在脏难愈也。且暑必夹湿，脾又恶湿，湿在脾，不易去也。治法当以辛凉解散为主，用药宜轻清上升，不宜重浊下降。经所谓火郁发之是也。夫脾为坤土，其气本升，既为淫热所蕴，已失健运之机，若早用普降之药遏住热邪，阻其上升之性，势必其邪由表入里，变成下痢而难愈矣。是以治当纯用辛凉解表，务令将辟经所沾暑湿之邪导其仍从麻胃而出，所贵提邪外越，勿使引邪入里，是为要着。尤不可杂以里药下药，杂则药便有所牵制，其力不专，难以奏效，更防邪易陷脾耳。因此症从无专治之法，兹特本诸前贤参以己意，聊拟一方，通病用之，多能获效，奉劝高明，请尝试之。

葛升汤 治热势起伏，有汗不解方。

葛根一钱五分 升麻八分 连翘。钱 杏仁去皮尖，二钱 炒牛蒡子三钱
六一散三钱 广皮一钱 蝉衣去足，一钱 川通草四分 香薷一钱 引用芦根一两
荷花露一两 鲜荷便一尺 鲜佛手一钱

分量视人强弱加减。虚弱之体升麻量减，强壮之人升麻酌增。

以上之味平淡无奇，人人皆用。惟升麻为此方必用之药，与六一散通草能提脾家之暑湿，使之外达肺胃。葛根、芦根为凉散阳明之专药，杏仁为心果，连翘能清心包络热，香薷、荷梗、荷露清其暑，广皮、佛手开其气。蝉得秋气最先，乃金风奏而炎暑消之意。更与牛蒡为解散暑风之佐使也。若大热前先手足厥冷者，病机已兼少阳，当加柴胡四分。时交白露而发病者，方中须加赤芍药一钱五分，乃邪气入营故也。再加薄荷一钱，以往香薷之不逮。若深秋后脉不甚洪，口不甚渴，当去芦根四钱，小儿则分量酌减。此方连服三剂或五剂，重者即轻，轻者即愈。或有变为疟疾，数日而愈者。若但热无汗，脉洪数而懊烦者，不用此方，用大青龙汤去姜枣加葛根，因暑蕴于中而外为寒所束也。

此方之用神，全在升麻一味。盖暑必夹湿，若脾中蕴湿则清气不升，浊气不降，暑湿之邪交阻则外壮热而内懊侬，舌胎黄腻，大便秘结，小便短少诸症见矣。惟升麻升其清气则浊亦易降，并助葛根诸药涤邪外散，可以效灵。如无升麻则难奏效。或云升麻非常用之药，抑恐阴虚之人提动肝阳，故不敢轻投。不知升麻入肺、脾、胃、大肠四经，非同柴胡之入肝胆可比，可以无虑。东垣先生亦常用之。惟胃虚气逆呕吐者，自宜慎用耳。且此症两候之内，若能早用此方，可无邪闭邪陷之虞，亦无气粗痉厥之险，业医者未可轻视也。又云：表里双解亦是前人之法，何以此症独不可用？答云：先表后里，古人治病贵有次第。表未解未可攻里，仲师亦尝言之。若邪势表轻里重者，偶用双解是专意攻里带疏表也。表重者断无此法。况治伤暑之症，务令将脾家所蕴之邪导其仍从肺胃而出，若用里药，不外槟榔、枳实、焦查、神曲、厚朴之类，性燥入脾，虽与肺胃之药同用，而药方有所牵制，不能提邪外越。里药若轻，尚无大患，倘或重投多服，则津液愈亏，元气愈弱。正虚邪陷，虽有良医，难为方矣。若杂下药则热邪陷脾，易成滞下，此所以谆谆奉劝世之业医者考之于书，揆之于理，验之于病，深望明哲之士颖悟而信从之。务将旧日所习之成法为之一变，则病者幸甚。

附录澄江华墅镇俯恬吴君阅此寄来书并答书

仪卿先生阁下：两奉教言，浣读大著，发前人之所未发，启后学之所未悟，业已黏之通行，广布仁风于大地矣。另附跋语于尾，并将臆见质之有导，尚析指教为幸。立论明畅，皆穷源探本之言，用药轻清，有批郤导窾之妙。洵为暑门宝筏，治喝良方。有裨来兹，功德不浅。江浙卑下之地，交春分以后即有热蒸湿郁之气，足以病人到五六七月尤甚，俗谓之湿温，即暑湿热三气合病也，经谓先夏至为病温，故曰湿温。后夏至为病暑，故曰伤暑。若暑湿潜伏三焦募原，乃半表半里之界，至处暑后新凉外束，伏热内动而发者，谓之伏暑。其候最难速愈，大抵转疟则轻，入里则重。从古无人发明此理，虽洁古以动静分阴阳，东垣以升得温燥为清暑，按之今病，殊为未备。淮河间刘氏理法清真如天水散、桂苓甘露饮，诚为三焦之妙剂，借引其端而未竟其绪。喻氏以暑湿热三气汇为一门，言之颇详，而于伏暑一症盖阙如也。意者自宋元明以来，其证尚少耶，抑当时有是病而以伤寒混治耶。闻张凤逵有《暑症》一书，购之未得，惟叶香岩前辈以江苏人言江苏病，独辟鸿濛，如曰暑与湿皆地中之气，无形无质，从口鼻吸受，不宜以重药推销。又曰：仲景伤寒先辨六经，河间温暑必究三焦，以手经为重，忌足六经药。片言扼要，允为后学津梁。瑛每见秋后伏暑，最属纠缠，患者极多，必转疟乃愈。若转滞下，乃邪陷二肠，宜宗喻氏逆流挽舟法，百无一失。若不先行逆挽，势必愈趋愈下，变为不治者甚多。又有早用黄连、石膏，致邪陷厥阴，变为痉厥神昏而成坏病者，十中仅救一二。瑛目击心伤，蕴于中者久矣。著有《伏邪论用代暑刍言》《痧麻》及《烂喉丹痧指迷》等说，俟脱稿后录呈，削政为荷。再接瘧症之说，《内经》与《金匱》所言大略相同，皆阴气先绝，阳气独发，但热不寒耳。惟《内经》言肺素有热，《金匱》言气藏于心，要不外心营肺卫之旨，细绎之，似冬令金水两亏之人，邪伏手太阴，足少阴

，至春三而发。有寒热往来者，有但热不寒者，有咳嗽者，有咳久失血者，与热病温病两感之病同源异流。治不得法，或误散或误补，迁延时日，每成损怯，故日令人消铄肌肉。似与暑病不符。贵邑明医甚多，以暑病为瘧症，其得之师承口授乎？抑别有所阐发经义而云热乎？循名核实，不能无疑，尚祈明以教我，曷胜幸甚。

甫恬先生阁下：接诵手书，藉悉起居安善，动定咸宜，以欣以慰。所呈瘧症浅说，皆属肤浅之论，或即为患者之一得亦未可知，乃蒙嘉奖过当，实觉汗颜。惟方中之葛根升麻并未论及，窃有所疑。然鄙意以为此方之关键全在此二味，盖葛根为凉散阳明之专药，若不以升麻、六一散佐之，尚不足以升举脾胃之暑湿，使之外达。六一散中滑石亦属阳明之药，必用六分而佐以甘草一分者，欲令滑石导入脾经，方能将脾之暑湿外泄也。古人制方之义如此，后人以为湿家忌甘草而专用滑石，大失此方之旨矣。古方中用升麻者甚多，何今之医士都畏而不用耶？即烂喉痧亦须用升麻。《伤寒论》中有越婢汤，以后诸家不明其义，强为解释，不知婢乃脾字之讹，越婢者，为发越脾气之义，故方中兼用姜枣，亦从脾经导邪之意，犹六一散之用甘草也。夫脾为坤土，位居中宫，为营血之源，上这则可传肺胃，下陷则易入肝肾。病机之出入，医家之挽回，须在此参究耳。所以东垣先生亦着意乎此。至于瘧症之名，乃通称，其实即伤暑也。此亦仍其旧而已。若无汗而用大青龙汤，亦自有说。世皆以暑月忌用麻黄者，盖以麻黄性温，非夏令所宜。又以夏月腠理已开，若再用麻黄，恐有汗多亡阳之虑，不知伤寒中之用大青龙因寒已化火，故有口渴脉洪烦躁之证。以麻黄、桂枝发汗为君，而以石膏之辛凉佐之，取龙腾雨降之意。此症脉洪数，口渴无汗相同，若不用麻黄、桂枝发汗，石膏清热，则汗无从出，而邪无从解。湿热蕴伏中宫，津液日伤，元气日耗，变症不可测矣。故必用斩关夺隘法以救之。不过伤寒以麻黄、桂枝为君，石膏为臣，此症当以石膏为君，麻黄、桂枝为臣，分量有轻重，贵在临症权衡也。经云：肺素有热，邪尚在卫。《金匱》言：气藏于心则入营矣。若不辨明营卫经络，概从气分发散，尚属隔膜，焉能愈病？所谓治不得法也。更有此种热邪，尚从上年伏于营中，冬令闭藏，至春而剧，医者当市其或在脾经，或在肝肾，对症用药，方能获效。若邪伏在脾胃营分，则右关之脉沉分必独洪数，先辈有以葛根、犀角并用，葛根散邪，犀角清热，二味为君，参入地味，最为合法。至或有咳嗽者，或有咳久失血者，皆属热伏营分之征。若迁延时日，每成损怯，及令人消铄肌肉，总是阴分为伏热所伤之故。若不知清热而但知用补，则大谬矣。清热总须邪有出路，不可一味寒凉，此病乃从前所伏之邪暑，病为暑月新受之气，故病不符，治各不同也。愚意如此，未识高明以为何如？还当有以教我为幸。高论中云：伏暑症必转疟乃愈，若转滞下，变为不治者多。此亦显而易见者。盖少阳为半表半里六经之枢机。转疟者，是太阴之邪传变少阳，由阴出阳也，故易愈。若转为滞下，则太阴而传入厥阴矣，故难治。可见伏邪亦应分六经，若河间之究三焦，似言受病之始，尚非伏邪之确论也。败毒方中之用柴胡、羌活，亦是从阴经导出阳经之意。故曰逆流挽舟，是从趋下之势而挽之使上也。由此悟入，一隅三反矣。

俯恬吴君又有书来并答书

仪卿先生大人阁下：闰月接展，还云详论瘧症，因夏秋忙甚，未遑握管，致稽裁复，抱疚无如。正深渴想，十月中又奉手教，诵悉福履，恒绥潭禧晋吉，以欣以慰。承惠《风雷集》及大著《医中一得》，浣读之下，仰见仁人用心，志在济世。至产后房劳论，发千古不发之蕴，诚为医中暗室一灯，尤征学识精进，不胜钦佩之至。惟荷蒙雅爱，垂问谆谆，谓如有别说，或尚有未到处，统祈示悉改正，不致贻误后人，更见虚怀若谷。瑛敢不以三十年临证考核之苦衷，心有所悟者为知己告？谨将下询原由及瘧症二字不可以伤暑混同立论之处，另单呈核，伏祈鉴定，正其纓，存其真，为幸。瑛与阁下，交有年矣，何幸而得此益友也。日后拙作告竣，寄阅之后尚望匡以不逮是荷。窃思医以活人，笔之于书，传之于后，立言宜万世无弊。若择之不精，便有偏而不全之处。敢将管窥之见与平日临症有得合于古而可信于今者，印证高明，尚祈赐教为荷。高论云：瘧症之名乃通称，其实即伤暑也。亦仍其旧而已。窃谓瘧症本于《内经》仲景，特发明《金匱》，盖实有是症也。考《说文》：瘧者，劳也，因劳生热（即《内经》阴虚生内热也）。故劳字从火从力，谓有所过用其力，则君相二火上越高颠，其病为热。此虽臆说，似与阴气孤绝，阳气独发二句颇合。因其但热不寒，故曰瘧。作止有时，故曰疟。大抵肾水不足，素多内热之人，冬不藏精，寒伏少阴，至春夏阳升气暖，邪寻出路而发于心肺，从上焦而达之也。喻氏论瘧症，主以甘寒，言之未能十分透彻。徐忠可谓与温疟同一机局，沈图南谓瘧症亦微有洒淅恶寒，至但热不寒，心阳发病，肺邪不能复，心为寒，故但热不寒。又曰：白虎加桂枝汤即前瘧症而出方也。喻氏谓心肺两阳合邪，故但热不寒。鄙意瘧症即疟病中之一症，《内经》列于疟论，仲景发明于疟门，谓伤暑乃瘧症中之兼症则可，谓瘧症即伤暑则不可。既登梨枣，似直立言无弊，不可拘于俗称也。谨奉劝分作二说，以为后学之一助。近诊患瘧症者甚众，非若伤暑寒轻热重，或寒热往来者可比。高论中有“经云肺素有热，邪尚在卫，起至此病，乃从前所伏之邪止”一段甚为明晰，可请将大著正其名曰《伤暑浅说》，另著《瘧症浅说》发明《内经》《金匱》奥旨，以启后人，庶几名实不混。高论越婢乃脾字之讹，为发越脾气，其说甚正。此一节发明脾胃病机，诚为治法之关键。大青龙有兴云致雨之能。说本柯氏，用之伤暑宜石膏为君，尤见卓识。鄙意麻黄虽与石膏同用，似非暑病所宜，用之于二三月瘧症之壮热无汗、大渴脉数大者似安。高论中邪伏脾胃营分则右关之脉沉分必独洪数，此明言之至确者，先辈有以葛根、犀角并用。尤为瘧症中阳明少阳经之的方。来札云：方中葛根、升麻并未论及，窃有所疑。然鄙意以为此方之关键全在此二味云云。细绎尊方，所主在脾，本东垣清暑益气汤来。东垣所论者脾胃也，立法全在中焦，一味升阳为主。如果邪在足阳明之经，葛根乃一定之主药。若在阳明之府，非葛根所宜。升麻为手阳明之主药，若邪在上中二焦，又恐药过病所，反伤无病之所。至香薷芳香清透之品，为伤暑之主药，于伏暑又非所宜。鄙意宜凭脉辨症，随症活法去取，有是病则用是药，所重在识症。医者识得真辨得明，不患无治法。尝考方者，则也，仿也，有一定不易之方，有随时交易之方。一定不易者，如胃家实用承气，太阳病无汗用麻黄，有汗用桂枝，不拘方氏三大纲之说是

也。随时变易者，以古方如明文时文取来看样，不可直钞一篇名作以应试。又如画家仿某人法、某人笔意是也。许学士云：予尝读仲景书，用仲景法，未尝执仲景方。罗太无云：用古方譬如拆旧料添新料，必经匠氏之手方善。来书云：伏邪亦应分六经，若河间之究三焦。似言受病之始尚非伏邪之确论，此言专主手少阳一经是也。试畅言之。河间温热主乎三焦，其说有二：一则专言手少阳经也，盖一岁有六气，自春分至小满为二之气，手少阴君火主令，其候温甚化火，自小满至大暑为三之气，少阳相火主令，其候热甚化暑。故温暑必从手经先受，亦犹伤寒必从足经先入也。此不独天时一定之运气，亦人身同气相求之至理。故叶氏论温热曰：温邪上受，首先犯肺。力辨以足经药治手经病之谬。又曰：河间法至精至妙，后医未读其书，焉能治病臻效。惜乎专以陶书六经治病等语，其叹服也如此。况三焦与手厥阴为表里，暑先入心，故逆传心胞最易。人身一小天地，谁曰不然，此实发明《内经》五运六气之奥旨，有功后学不浅。一则统人身上中下之三焦而言，不专主乎手少阳一经立论也。经曰：上部天，中部人，下部地。又曰：上焦如雾，中焦如沤，下焦如渌。是人身之有三焦，犹天地之有三元也。试以太阳经而论。起于目内眦，上额交巅，则自头项至心肺之俞，太阳经之上焦也，自背至腰脊命门穴，太阳经之中焦也，自肾俞至足少阴穴，太阳经之下焦也。举一经而六经皆有，上中下可以类推矣。故上焦法天，纯乎清气，在脏为心肺之部，上焦之邪必在初感，其病浅，药用轻宣透达，药重反过病所。上焦失治，传及中焦，其病深矣。中焦法人，为气交之中清浊之界，在脏为脾胃之部，其受邪也，阳明独多，如省垣都会，万物辐凑也。有在经在腑之别，不可混治。实投攻下，热用寒凉，虚进参芪，寒宜姜附，瘴疔可破可逐，湿热可清可燥。中焦失治，传入下焦，伤及血分，其病笃矣。下焦法地，纯是浊阴，在脏为肝肾之部，药用滋填。火则清之，寒则温之，湿则利之。下焦失治，伤及肝肾，十难救一矣。仲景六经发明于前，河间三焦辅翼于后。一经一纬，如日中天。仲景六经非专为伤寒设，此内伤外感不能舍六经而言症言治也。举足经而手经亦包括在内矣。河间三焦非止为温暑设，凡外感内伤亦不能外三焦而言清言浊也。明得三焦而十二经皆在其中矣。所以时贤吴鞠通著《温病条辨》，汪瑟苍侍郎详加评点，发明上中下三焦症治，虚实寒热，不惮烦言，良以世之人不明温暑指归，不究三焦深浅，特为唤醒，弹克遵循，诚医门之一火炬也。质之高明，未识以为然否也。高论产后房劳可为万世规，则补气通血一句乃不刊之论也。两方一治全实者，一治半虚半实者。鸡冠一味尤征。格物精确，读此明快之书，令人心开目爽，舍下家秘女科中采有经验之方，宜于藜藿而不宜于膏粱。尊方则贫富皆可用，惟已成咳嗽寒热者，未识有何妙法。室女经闭成劳有血枯而闭者，郁损而闻者，尤为难治。统析教以不逮，曷胜幸甚！

俯恬先生阁下：接读手书，藉悉交棋佳畅与序更新，欣慰奚似，承示教言，皆有根据，并无杜撰，足征学有渊源。凡读古人书，应先胸有识见，引伸触类，融会贯通，当悟乎书之外，勿泥乎书之中，方为善读书人。若以瘴疔为劳症，为阴虚生内热而发，及冬不藏精，寒伏少阴等说，恐非。夏月所发之病，识之不真则治之下的。无怪遇此症延之日久而无效矣。此则但热不寒者则为瘴疔，寒热往来者则为疟疾。

二症俱由伤暑得来，暑湿之邪传入太阴，与阳明合病则成瘧症。暑湿之邪传入太阴，与少阳合病则成疟疾。所谓夏伤于暑，秋必疟疾也。知病在大阴少阳，须用柴苓，是将太阴之邪提归少阳测知病在太阴阳明，须用升葛，是将太阴之邪提归阳明也。何以此病之邪不离太阴脾经者？盖则每日起伏如是，乃脾主信故也。因此症敝邑之医皆称瘧症，若别立名目，人必不知指何症而言，是以仍其旧也。人身有二火二土，肾火生脾土，心火生日土，脾胃二土位居中宫，一阴一阳，一表一里，一脏一腑，一升一降，运行一身，相须为用，即身中之太极，犹河图之五十居中也。经曰：饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行。此之谓也。自湿热蕴阻脾经测不能与日相配行其津液矣。仲师云：阴气孤绝者，是太阴之气孤绝也。阳气独发者，是阳明之气独发也。阳明之阳亢而无配，故但热不寒也。玩孤独二字，便明下即云邪气内藏于心，外合分肉之间，心为胃之母，肌肉为胃所主也。内藏于心，故烦冤。外舍分肉，故肌肉消烁也。非指阳明而何所指乎？即如白虎加桂枝汤，非阳明药乎，非足经药乎？加桂枝者，为石膏之反佐，以助辛散之力，兼能入营发汗也。若无汗之瘧症必须发汗，则邪始透达。若不用麻黄、桂枝，将有何药以令发汗乎？如不得汗，则邪从何解乎？仲师之立麻杏甘石汤方，亦为热邪在肺而设。若本阳虚之体，麻黄原不可轻用，恐再亡阳也。夏月表疏，不可重虚其表，古人之言似因有汗者而发。若无汗而热邪蕴结不解，而用数钱之石羔，少位数分之麻黄，亦属经权之道。若恐汗出不止，则止汗之方甚多。邪解之后选而用之，亦无可也。若但用麻黄而不兼用枝枝，尚恐汗不速发，盖以汗为阴液，麻黄但能入气分而桂枝则兼入营分矣。故桂枝汤中无麻黄，而麻黄汤中有桂枝也。因风伤卫不可用麻黄，寒伤营须兼用桂枝也。瘧症为夏至以后之病，若在二三月间，尚无瘧症。惟温病则有之，所谓冬伤于寒，春必病温也。若夏月之症，即将太阴所沾暑湿之邪及早提归阳明，清而散之，又何有伏邪窃发，自冬至春变成难治之症哉。无汗之瘧症两候内有大青龙去姜枣加葛根，若两候外则忌用，恐津液已伤，不可强逼其汗，重亡津液也。脉洪数而实，仍烦冤者，参用白虎加桂枝汤等方，后此再用甘寒之法可矣。吴鞠通《温病条辨》论症立方，其说理精透处固属不少，其间未是处亦不能无。瑜不掩瑕，未可一概论也。兹因心力不逮，惜不能通本批评耳。至室女经闭成劳与产后房劳症不月同，而所以不月则不同。经云二阳之病发心脾，有不得隐曲，女子不月，此因不得隐曲则肝木郁而不伸，肝郁则病及于所生、病及于所克，故发于心脾也。心主血，脾统血，肝藏血，三脏均郁，故不月也。此症当从木郁达之之例，宜用加味逍遥散参入桃仁、红花、延胡、贝母、生地之类。十数剂后，再用通瘀决津大黄（庶/虫）虫丸之属以治之。体极弱者，亦可加用人参，务须药及病所，不可病重药轻，当以经通为断耳。若已成咳嗽者，是木火刑金，未可与感冒并论也。诗曰涉彼阿邱言采其虻虻，即贝母能活郁也，故宜参入。愚意如此，还请高明有以教之。知阁下好学深思，旁搜博采，更兼虚以待人，故敢以鄙陋之见冒昧直陈，盖彼此讨论，庶能于此道鞭逼入细，不致贻误后人。或可藉为启悟而有种来兹，未可知也。瘧症，魏柏卿注为热毒，则视温症较重。仲师治瘧症用白虎加桂枝汤，则瘧症用大青龙去姜枣加葛根可类推。去姜枣者，姜性烈，枣腻滞也。此独为瘧症初起立法。若延至日久，则症已变而治法亦变矣。

。《金匱》瘧症条中云：阴气孤绝，阳气独发。此二句是仲师发明瘧症之病源，盖阴阳不相配为之孤，往来不相通为之绝，阴气孤绝故阳气独发也。此所以脾不能为胃行其津液而为病也。若非如此解，须知仲师原文一字不苟，孤绝二字甚重，试细思之人，可阴气孤绝耶？白虎加枝枝汤与大青龙汤，其中所用桂枝均当去皮而用本，盖皮性大热，本性温和也。

大青龙加味汤

石膏六钱 麻黄八分 枝枝四分，去皮 杏仁去皮尖，三钱 甘草五分 葛根一钱五分
分两临症加减。

产后房劳论俗称产母病

妇人生产二三月后，身忽发热，逾时暂解。数日后身又发热，仍复暂解。始则数日一发热，继则两三日即发热。后则连日脉数身热，不能暂解，身体困倦，饮食渐减，面色萎黄，或似外感，或似内伤，咸为蓐劳。但蓐劳乃产后月内之病，因坐草艰难所致。此则生产二三月后之病，与蓐劳似同而实异，俗称产母病也。医者调治，始用发表疏解治之，不应，旋用养阴清热，后用健脾开胃补虚等药，总归无效。其人日见困顿，热仍不解，脉象虚数，沉分带弦，一病淹淹，渐成劳怯，遍考方书，既无确论，又无专方，医家无所折衷，只好束手坐视而已，殊不知此症都由生产一月之内，八脉空虚，恶露未尽，夫妇同房，致将恶露阻住子宫，不能尽去，是以血络日渐瘀积，则气亦生滞，一身气血不能昼夜流通，而营卫不调，身热作矣。初不甚觉，以后血愈积则身愈热，身愈热则气愈弱，而血愈积，遂成干血劳症而难治类。疗治之法不外补气通血四字而已，盖气为血帅，若气不足则瘀难通，故补气通血不可偏废也。失血热则行，血寒则滞，若但知养阴清热则血更滞，而热更甚。热久不解，势必血渐涸而气愈馁，欲望不成，劳症得乎。谨录两方，临症加减，聊为此症之规法，庶几后之学者有所适从焉。

延胡索散 专治妇人产后房劳。

延胡索二钱 生赤芍二钱 生蒲黄二钱 上肉桂二钱 琥珀二钱 当归二钱 红花二钱 右药用
好醋浸一宿，共为细末，每服二钱，七服而尽，陈酒送下。如虚弱者，用参汤送下。

八珍加味汤

川芎一钱 全当归醋炒，三钱 赤芍一线五分 熟地四钱 人参三钱 云茯苓三钱
冬术土炒，三钱 炙甘草六分 广陈皮一钱 桃仁泥三钱 新绛一钱 苏木一线五分
五灵脂三钱 上桂心五分 延胡索一钱五分

引用生姜三片，大枣二枚，青葱管三根。再加大红鸡冠花一两，如用干者减半。

以上之方，补气用四君子，补血用四物汤，行气用陈皮、延胡，行血用桃仁、新绛、苏木、五灵脂。用桂心者，血得温则不滞也。引用姜枣，和其营卫，青葱管直走冲脉，红鸡冠《纲目》但言活血，却能引领众药导入子宫，为此症必用之专药。因其形假猪胜中之生窠，故为子宫之引经。此说得自宜兴屠渐斋先生所传，非臆说也。如无人参，以潞党参八钱代之，加酒一杯煎服，十剂必有效验。如月分尚浅，气血少弱，则服前方。若月分已多，气血大伤，则服后方。

咸丰四年仲秋锡山顾文山氏识

附录医士王君痺症辨论

细读尊论所云：痺症多由伏暑而成，如暑必挟湿，邪伏太阴，太阴与阳明合病则为痺症，太阴与少阳合病则成疟疾，以及阴气孤绝，阳气独发等说，皆极明畅，佩服之至。然以愚见观之，伏暑自有伏暑之病，痺症古有痺症之名。锡邑医家所称痺症伏暑之病居多。澄江诸医所称伏暑，其间亦有痺症，何以辨之？须知痺症热症也，细玩经文，如肺素有热，及邪气内藏于心，外合分肉之间，热而少气烦冤，消烁肌肉等句，则知夏秋痺症暑热居多。暑伤气，故云少气，暑先人心，故云邪气内藏于心。古方白虎汤、竹叶石膏汤乃痺症正治之法也。近时薛一瓢立清症饮，亦从清解立法。至于白虎加桂枝，必见大热烦渴，而又背独恶寒，骨节烦疼，方可加用程云来《金匱注解》谓白虎清气，桂枝入营，治在心营肺卫，徒属纸上空谈，令人好看。恐尚非确论也。若夫伏暑初起，微寒微热，起卧自如，舌有白苔，胃能饮食，食亦无碍，不食亦不饥，淹缠旬日而后病势渐重，此真所谓伏暑，乃湿热二字为病也。治暑病与伏暑，喻嘉言暑门诸方论可云详备，再参薛生白湿热论三十三条，新法颇多，可应无穷之变。高明谅必洞悉，兹不烦缕述矣。按古语暑属火，暑必挟湿，暑伤气，暑喜归心，暑邪留恋上中，弥漫三焦等说，为治各各不同，故治暑之方温清消补，解散通利，亦种种不一，统以见证为凭，未易一言尽也。尊论升葛亦创一新法，确有意义，可法可传，有稗来学。世多明哲，自有定评，无俟鄙人诵也。

答书

接阅尊论，至为明晰，钦佩奚似。惟此症自夏至以后至初秋发者，谓之痺症。自深秋至初冬发者，谓之伏暑。其实皆伤暑得来。伏暑者，秋凉已深，暑邪伏于营分也。而尊见以为伏暑，自有伏暑之病，痺症古有痺症之名，似以此病忽分为二矣。然则古有痺症之名，自有痺症之实，将以何症为痺症耶？抑古有痺症而今无痺症耶？捧读之下，令人不能无疑。仲师制白虎加桂枝汤，自有深义，而足下以程云来注解为纸上空谈，则从古圣贤所论都在纸上，岂亦谓之空谈而不能见诸实事耶？仆非精于此道，亦非行道之人，然既有疑，不能不问，还当明以教我为幸。

《黄帝内经》，千古不磨之作，所言经络脏腑腧穴、阴阳五行、运气，非神圣不能道只字。仲景《伤寒》《金匱》亦千古不磨之作，有论有证，有方有法，多一味便不是此方，异一脉便不是此证，非神圣不能道只字。第《内经》所言者是体，仲景所言者是用。此二书实体用相须之要道也。瘧症一症，《内经》《金匱》俱载之，但未竟其详耳。大凡四时为病，冬月即发者谓之正伤寒。然冬寒而反暖，即有冬温，至于冬伤于寒，至春变温，至夏变热，即谓之伏气矣。故发于春末夏初者，便谓之温热病。温热病中间或有温瘧之形举，俗所称春温似瘧，春温瘧，湿温似瘧，湿温瘧。或师承相授，或习俗相传，亦非漫然而称之也。大抵夏至以后而病热者，谓之热病，新书《温病条辨》中所云暑温是也。挟湿者谓之湿温，湿温症治，古方用苍术白虎，则知无湿。而但热者，白虎汤是治暑热之正法矣。今时酷暑炎蒸，忽起凉风雷雨而病者，是暑热为暴寒遏伏，先用香薷解表，数剂之后，忽变大热大烦大渴，而又背独恶寒，骨节烦疼，白虎加桂枝恰当。由是观之，白虎汤治暑热之正方，挟湿则加苍术，兼寒则加桂枝，岂不明且确也。程云来注解白虎清气，桂枝入营，非不有理，然欠畅达。鄙人无学，何敢批驳前贤。然而认证用药，要归着实。如柯氏《来苏集》改正越婢汤证，非有胆识者不能读古人书，须自具见识，勿为古人瞒过者，类如此。夫大暑以后，立秋初际，每多但热不寒，即是瘧症。寒热往来，便为瘧疾。当此之时，其治尚易，因暑邪内伏未深也。逮至秋分之后，寒露霜降，则邪伏递深，而其为病亦重矣。夫岂伏暑门中而无瘧症之症哉！仲景云：太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒体痛，呕逆脉紧，无汗者，名曰伤寒。若脉缓，有汗者，名曰中风。是从伤寒中分出中风也。若夫瘧症，是热症也，虽当初起，必见热重烦冤，舌红无苔，或有苔而亦甚薄，与伏暑之初起微热，淹淹舌上苔滑者不同。由是观之，虽届深秋，其病初起，热重烦冤者，即属瘧症，便不得谓之伏暑矣。暑湿内蕴，微热淹淹，舌苔白腻，虽系秋初，便与伏暑相类，但不名伏暑而名湿热病耳。尤在泾解风伤卫、寒伤营二句，云：寒之浅者仅伤于卫风，而甚者并及于营。卫之实者，风亦难泄，卫之虚者，寒犹不固。古称大青龙治风寒两伤营卫之法，诂知是中风卫实之方。风为阳邪，内郁化火，烦躁特甚，故用石膏。卫实无汗，发热恶寒，故用麻桂。此语独超千古。又有暑病解云：暑属火，暑必挟湿，故阴虚多火者暑即寓于火之中。阳虚多湿者，暑即伏于湿之内。此亦名言，非同泛泛。由是观之，患瘧症者，阴虚火盛之人为多，即经旨肺素有热之来路也。患伏暑者，阳虚湿胜之人不少，即湿性滞濡之意也。惟湿郁必化热，六气皆从火化，故湿热伏暑，病亦有化燥而用清法者，不可不知。乃若瘧症燥热居多，清解是其正法。清解维何，辛凉是也。如薄荷、牛蒡、桔梗、连翘、豆卷、青蒿、竹叶、芦根等味因其病方初起，后人不敢用白虎开场，但用轻清凉解，取意则同，而命剂悬殊矣。仪翁先生好学深思，特举葛升为瘧症开首之法，岂不另具卓见。第伏暑之病，邪居足太阴脾为多，用升葛从脾胃提出伏邪，颇有意义。若瘧症邪居手太阴肺为最多，肺主一身气化，为清肃之脏，似宜轻清解散为稳。病情变化，不可胜数，处方定法，统以见症为凭。故瘧症见虚者，加沙参、麦冬、洋参之属，挟湿者，加芦根、滑石、川通草之流。果热甚而大烦大渴者，则竟用白虎。热甚而挟虚，则白虎加人参或竹叶石膏之类。热甚烦渴，过饮水而挟湿者，河间五苓三石甘露饮最妙。如上症挟湿而

又停浊者，子和甘露饮尤妙。要皆不离肺热二字，而后传布三焦，生津降火，补气养阴，总以肺胃为主，未及脾肾。又为病湿后培元之着矣。此痺症治之大略，未足为明者道也。虽然病变无常，方难执一，以余阅历，同一病也，而体气不同则治法变矣。张璐玉《医通》有兼症晰义两卷，最为明晰，暇日观之，足令人心机活泼。叨居爰末，冒昧直言，伏祈垂察是荷。

答书

接阅高论，引证明备，说理精详，足征学问渊深，钦佩奚似！然《内经》《金匱》以及后贤方论诸书，苟从事于医者，无人不览，无烦赘述也。鄙人因见夏秋所患伤暑之症日久淹缠，变症莫测，医家治之，不能速愈，是以稍抒所见，发此微论，专指有汗之痺症、无汗之痺症二症而言，并未旁及他病也。若是春温、冬温、湿温、温热等症，或有伤寒中来者，或有感冒时邪者，或有伏邪感新邪而发者，症不一端，治不一法。若欲缕晰条分，非一纸所能尽，《温病条辨》中亦已言其大略矣。夏秋之症，有但热不寒而无起伏者，有乍寒乍热而无定时者，俱与痺症有别，不得以痺症之例一概治之。此中有冬伤于寒，邪伏在内，至夏感暑引动而发者。有极重之症不可不知，即论夏月伤暑之病亦多，而痺症则暑病中之尤甚者也。古人谓夏伤于暑，秋必痾泄，未尝言夏伤于暑，春必痾泄也。可见痾疾为秋月之病而非春月之病明矣。夫春月之病亦有似痾者，乃伤寒中之涉及少阳而然也，如竟与秋后痾疾同论则误矣。更有营卫虚而往来寒热者，此系大虚之候必于脉象见之，应当议补，医者亦不可不知。《内经》《金匱》将痺症列入痾症一门，则痺症为夏秋之病而非春月之病亦明矣。古人谓先夏至为病温，后夏至为病暑。可见时令亦不可不论，七月为之初秋，九月为之深秋。若以初秋之病为伏暑，转以深秋之病为痺症而不为伏暑，并为春间亦有痺症，不知出于何书，望为明示，以广见闻。若习俗相传，虽有师承口授，终非前贤确论，未可信为实然也。伤暑之症本应有汗，若痺症而至无汗，必因内蕴暑邪，外为凉风所遏，则肺气不达，腠理闭塞，故致无汗，其有汗之痺症尚须辛凉解表，至于无汗之痺症则非牛蒡、薄荷、桔梗、豆卷等所能胜任矣。非不知更为稳当，其如屡投无效，何举世茫然罔觉，不能一悟，良可慨已。因而想到大青龙汤去姜枣加葛根为法，方中重用石膏为君，少加麻桂为反佐，则无汗之痺症庶能发汗而邪可解矣。反佐者如白通汤之用猪胆汁，滋肾丸之用桂心是也。痺症魏柏卿注为热毒，视温症较重。仲师论温症用白虎加桂枝汤，则无汗之痺症用大青龙去姜枣加葛根亦可类推。去姜枣者，姜性更烈，枣恐腻滞也。加葛根者，凉散阳明之邪也。不过伤寒以麻桂为君，痺症以石膏为君，若用数钱石膏而以数分麻桂为反佐，亦可无虑。且无汗痺症，必热势起伏，日有定时，口渴烦冤，脉洪数，重按实者方可用，若似痺症，原不可用，当须识此，不可误也。古人处方，此一味重、彼一味轻，与此一味轻、彼一味重便即法不同而治各异，医者贵在临症权衡也。况此独为痺症初起立法，若延至日久，则症已变而治法亦变矣，岂可胶柱鼓瑟哉。《金匱》温症条中有筋骨烦疼，若谓背独恶寒则未之及也。至痺症之初起，病情已载痺症浅说内，兹不复赘。至于病变无常，方难执一，无人不知，不待言矣。从前二弟媳素本

耐性，偶患疟疾，因将出汗，心中烦躁，遂令打扇，以致汗不得出，邪不能达，终日烦躁异常，遂请令业师医治。议用麻杏甘石汤似矣。鄙意欲加桂枝数分，伊囿于俗见，坚执不肯，以致不效，至今深悔。可见业医者贵有胆识，独具卓见，方能超乎流俗，不致貽误无穷斯可矣。鄙人并非好为辩论，因世俗医之一道皆是浮光掠影，随声附和，毫无实际，不能独出己见。此等本不足与深谈，惟旭翁先生博学明理，超出庸众，心存济世，历练已深，故敢将鄙见直陈。盖医理本不易明，若能彼此讨论，刻意精求，庶或差少错误也。未识高明以为何如？荒谬之见，不知所云，还请教以不逮为幸。

接阅高论，谓时令不可不论。诚然，诚然。夫春温、夏热、秋凉、冬寒，四时之正气也。然春正月余寒未解，交惊蛰节而后阳气方升。秋七月余暑未消，交白露节而后阴气始降。夏至一阴生，正为热盛之候。冬至一阳生，正是寒极之时。盖剥不极则不复，理势使然也。经云：先夏至日者为病温，后夏至日者为病暑。由是推之，则知先秋分日者为病暑，后秋分日者为病凉(补天石有秋凉伤寒之说，凉极而后燥，交九十月燥病方生)。先冬至日者为病燥(喻嘉言补秋燥论谓经文脱却长夏伤干湿，以致后人不明秋伤于燥、冬生咳嗽云云)，后冬至日者为病寒。先春分日者为病寒，后春分日者为病温矣。常见春末夏初温病流行，阖门传染，屡经反覆，延至夏至后小暑节仍有战汗而愈者，原属温邪，非关伤暑，此则病之余气，非时之余气也。又常见夏至以后起病有似温邪。延及小暑节，热势朝和，过午则盛，但热不寒，竟与瘧症相同，此温暑之交，抑或所谓温疟耶。喻氏云：夏伤于暑，长夏伤于湿。由是推之，初秋瘧症，夏伤于暑之为病也，深秋伏暑，长夏伤于湿之为病也。瘧症由乎夏伤暑，故热症多而病势重，病重故不易速愈也。伏暑由乎长夏伤湿，故湿症多而病势缓，缓则淹缠，故亦不易速愈耳。

再阅高论，所云无汗之瘧症必因内蕴暑邪，外为凉风阻遏，肺气不达，腠理闭塞，亦诚确论。借用大青龙汤，重用石膏，少佐麻桂，亦无不可，但必重用石膏清肺胃之热，则知瘧症责重肺胃无疑矣。尊见亦明知瘧症病在肺胃，第以为肺胃之病意见相同，不遑多赘。至于白虎加桂枝，骨节烦疼，见《金匱》背独恶寒句，见伤寒审证集，引证用方要归着实，此即着实处也。语云：读书多不如临症多。果能读书、临症二者皆到，更为美备，惜言之易而行之难。其惟终日劳劳，荒疏无学，辱承教示，冒渎粗陈，伏维叹政。

答书

《金匱》瘧症条中云：阴气孤绝，阳气独发。此二句是仲师发明瘧症之病原；盖阴阳不相配为之孤，往来不相通为之绝。阴气孤绝故阳气独发也。此所以脾不能为胃行其津液而为病也。若非如此解，须知仲师原文一字不苟。《内经》云：阴气先伤。此特易以孤绝二字，其义甚重，试细思之，人可阴气孤绝耶？此等精义从来未经人道，虽读仲师书，犹之未读耳。书义未明，何能识病？既不识病，何能治病？徒夸临

症多无益也。可见医之一道，行之固难，言之亦非易，须知此症因脾为暑湿所阻，不能为胃行其津液，为病则其病在脾之暑湿可知。然则脾之暑湿将何从而使之也乎？其暑湿先既从肺胃而入脾，自必仍从脾而达之肺胃，方为正治也。医亦知从肺胃达邪，然于无汗之瘧症，但用牛蒡、薄荷、前胡、桔梗等，恐不胜任，方中并夹入厚朴、槟榔、焦查、神曲、枳实等类，以为非此不能解其满闷，消其积滞。不知此等之药其性温燥耗气，既非暑湿之邪所宜，并恐牵制肺胃之药不能得力，又恐屡投多服更伤元气津液，是邪未达而正已伤。并因正伤而邪易入里，贻误可胜言哉！从以为胸中懊侬烦满，必须积去而邪可解，殊不知邪解而烦满自除，此所以治病必求其本也。古人治暑湿，制六一、五苓、四苓等散为法，盖以暑中之湿宜渗宜利之故耳。至于白虎加桂枝汤，后人不明制方之义，以为既用白虎以治热邪，何以参入桂枝之辛温，殊不可解。苦思力索，想到必因背独恶寒之故，其为颖悟独神，随令一人唱之，百人和之，矜为着实之处。不知仲师于白虎汤加入桂枝大有深意，因湿症之湿热蕴阻中宫，若投白虎，恐或格拒，必用桂枝之性温为石膏之反佐，又以桂枝之味辛助石膏之辛散，并能入营发汗，更将阳明之热邪导其从太阳之表、太阳之里而出，以为温症之引路也。若必待背独恶寒方始用白虎加桂枝汤，倘遇温症而背不恶寒之症，竟不能用此方，坐失机宜，贻误不少矣。夏月伤暑之症甚多，而瘧症为暑病中之最重最难治者，历来名医不少，独于瘧症略而不详，以致后人罔有指归，只得恪守师承口授之妙法，表里双解，不辨经络，不明营卫，不分虚实，概以世俗所用之药，世俗所用之方杂进乱投，以致邪气由表入里，变成或痢或闭或陷之病而不一悟，深可哀也。即如屡承明示，亦不过博采群书所载夏秋各症为言，并未专指瘧症一症，究竟如何治法方为的确，以使无学人顿开茅塞也。鄙见如此，特请大才斧政，如以为不然，还祈指示何处未是，何处不从理上说来，何妨细加驳斥，使之佩服。眼见之多，胸中之亮，为嘱，伫望伫望。按《素问》症论帝曰：瘧症何如？岐伯曰：瘧症者，肺素有热，气盛于身，厥逆上冲，中气实而不外泄，因有所用力，腠理开，风寒舍于皮肤之内，分肉之间而发。发则阳气盛，阳气盛而不衰则病矣。其气不及于阴，故但热而不寒。张介宾注云：肺素有热者，阳盛气实之人也。故邪中于外，亦但在阳分而不及于阴，则但热不寒也，

又按：邪气内藏于心而外舍于分肉之间，令人消烁脱肉，故命曰瘧症。帝曰：善。注云：气藏于心，阳之藏也。热在肌肉之间，故令有消烁。然则瘧症之所舍者在肺心两经耳。其但热而不寒，在阴气先绝，阳气独发，则少气烦冤，手足热而欲呕，名曰瘧症。注云：瘧，热也。阳邪独亢，故但热不寒而烦冤少气，表里俱病，故手足热而欲呕，以热邪及于胃也。

愚按：此《内经》专言瘧症之病原也。首条所云肺素有热，以风寒舍于皮肤之内，分肉之间而发等文，即世俗所谓新凉引动伏热，先宜解表。

仪翁先生所云无汗之瘧症宜仿大青龙汤，重用石膏，反佐麻桂，内清肺热而外散风寒，深与经旨相合。再按第二条邪气内藏于心而外舍于分肉之间，即仪翁先生所引

白虎加桂枝症也。肺主气，白虎专清气分之邪热，桂枝能入心营，引领白虎入营清热，外解分肉之邪，论理甚合，似乎不必有骨节烦疼、背独恶寒之见症。然医者之用古方，必凭症凭脉，更合之以病情而后用之。若但任意测度病情，舍症舍脉而曰某病在某经，必用某药，吾恐论理虽是而用药则非矣。

附薛生白先生论温症、瘧症辨白虎加桂枝之不合

薛生白曰：温症瘧症，噬金匱》云：但热不寒，以桂枝白虎汤主治。程云来解云：用桂枝于白虎汤中，引白虎之辛凉而出入营卫，制其阳邪之亢害。此论理之当，然究属纸上空谈，余屡用不应，则知是方不中病情，投之不见其撤热之功，反见其营热烦躁之害。细推其理，症为久伏之邪，非一剂二剂可愈之症，石膏徒足以郁邪，桂枝反热其营，故不中病情也。余制一方，治温症瘧症颇效，今载是编，告之后人。

清症饮方

青蒿 蜀漆 知母 括萎根 淡芩 鳖甲 丹皮

再按；第三条但热而不寒者，阴气先绝，阳气独发，则少气烦冤，手足热而欲呕。愚按：阴气先绝，即首条肺素有热之对面也。肺属金而位居上焦，阴自上生，阳从下长，故肺为水之上源。肺素有热，则水源绝，阴气不生故曰阴气先绝。阴气绝则阳独亢，故曰阳气独发。阳气独发，故但热而不寒，令人少气。肺主气，热伤气也。烦冤者，心为阳脏，即第二条邪气内藏于心之见症也。手足热而欲呕，因四肢为诸阳之本，胃为两阳合明之经，故手足热而欲呕也。细玩经文，则知瘧症为热邪，外为风寒引动则病发。其病在心肺胃三经，并未言及足太阴脾字样。注云：瘧热也。则知真正瘧症但有热而无湿，其不干足太阴脾明矣。其有挟湿者，在初秋仍属暑病，在深秋即属伏暑，又非真正瘧症矣。语云：名不正则言不顺，欲正瘧症之治，先正瘧症之名。尊论云：书义未明，何能识病？今因将《内经》原文并先贤注解抄录呈政，伏祈明察是荷。

答书

尊见以为阴气孤绝是手太阴肺经之阴气孤绝，并非足太阴脾经之阴气孤绝。但《内经》云阴气先绝而仲师特易以阴气孤绝，自有深义。若如此说，则孤字无着落矣。孤字无着落则独字亦无着落矣。且肺之阴气孤绝是竟为尽绝之绝，若肺之阴气尽绝尚得为之人耶？前所言足太阴脾经之阴气孤绝是脾中为湿热所阻，不与胃相配，乃隔绝之绝也。且此病之邪，若未及太阴脾经，何以热势起伏，每日如是乎？常见治不得法，每致邪易入里面成滞下，此症既与脾无涉，则滞下亦与脾无涉乎。此真所谓任意测度矣。脾主四肢，手足热者，即邪热蕴脾之见症也。至于白虎加桂枝汤，乃仲

师所制之方，其义非寻常所能测识。仲师为医中之圣，如薛生白不过近时之名家耳。若以仲师之方为不足法，而以薛氏之说为大可师，是子贡贤于仲尼矣。瘧症既为热邪，是暑病无疑矣。若云无湿，则暑必夹湿之谓何？不过湿有轻重也。舌苔之黄腻即是湿热之见症。若夏月之症壮热无汗，口渴烦躁，脉象洪数，邪势起伏有常而不为之瘧症，将如何之？病而为之真正瘧症乎？考之《内经》《金匱》，温症与瘧症大有不同。瘧症乃夏月伤暑之症，温症自伤寒中来，化火而成热症。因骨节疼烦，故用白虎加桂枝汤，而薛生白以清症饮统治二症，称为颇效，有识者似未敢深信。叶氏云；青蒿减柴胡一等。自有此说，医家凡病中须用柴胡者，则以青蒿代之，多所贻误。盖柴胡入气分，青蒿入营分，柴胡主升，青蒿主降，大有分别也。不过柴胡、青蒿俱属少阳经药耳。若邪入营分而寒热往来，自用青蒿以清泄胆经之热为宜。若症邪初起，尚在气分，早用青蒿有引邪入营反致淹缠之虑，医者亦不可不知。愚见如此，还请高明斧政为荷。

七月中，若能于无病时将此葛升汤原方分半月内预服三剂，则暑邪表散，秋后不致患瘧症疟疾，并无伏邪矣。已试过几人。

送子神效方

原传之方系四川用成都府崔照磨，年七十岁，赴京遇户部郎中周士富相叙，二人同庚，得传此方。崔照磨妻年已七十，服之面如童年，经水复来，一交成孕，连生二子，奇怪已极。有崔附张遴寡妇陈氏年六十二岁不信，吃药偶亦试之，果若童年，随即有孕，更怪矣。奈孤阴无阳，堕胎而无骨。又有诸学士妻赵氏年已四十五岁，服此药连生四子，神化莫测，真仙方也。此药添精补髓，更治五劳七伤，功难尽述。今系赣州府金太守面看此方，力劝制服，据有武官总爷年老无子，因服此方，连生二子。人在世间，方便第一，不可秘密，宣传此方，功德无量。

澄茄二两 蜘蛛十四个，阴干 母丁香二两 山萸肉二两 西四钱 巴戟肉二两
当归二两 牡蛎二两，煅 大茴香二两 干漆二两，炒 大熟地二两 四钱 威灵仙二两
全蝎五钱，去尾 车前子二两 云苓一两 四钱 龙骨二两 蛇床子一两 四钱 萆薢四钱
肉苁蓉二两 四钱 桑螵蛸一两 四钱 远志肉二两 沉香三钱
木通二两 四钱 广木香一两 四钱 菟丝子二两 马兰花八分，阴干研 灯草五分

右药念陆味各研极细末，炼蜜为丸，如绿豆大。

煎方

桂枝三钱 甘草二钱 白芍三钱 姜皮二钱 共一两，再加白糖饴二钱，大枣三枚
右药每月到转经期服一帖，此方甚灵，近来眼见已效三人。

葛升汤验案

子家女孩年十四岁，于七月初忽然患病，三日后始行告知，呕吐不止，胸中懊依极甚，昼夜不安。切其脉沉细而数，自言心中觉热而外身不热。请医看视，方中虽有发表之药，而参入川朴、磨枳实、莱菔子等味，以为表里双解。予为断不可用，即用葛升汤。因其吐不止，方中去升麻，以淡芩三钱代之。外不热而脉不扬，去芦根再加薄荷根四钱，玉枢丹四分，磨冲，希其得汗邪解。服两剂后，头上稍有微汗，吐虽止而懊依如故。再四踌躇，细思此症，必因内蕴暑邪，外为寒气所遏，是以身不热而脉沉细数，懊依者，即暑邪所伏也，遂于原方中去玉枢丹，加入桂枝木六分，芦根四钱，取白虎桂枝之意。服后即一汗而解。加芦根而少用者，因桂枝辛温，非暑日所宜，故以芦根监制也。后遇此等症，可以为法。

咸丰八年，陆氏外甥方官年七岁，秋患有汗瘧症，与服葛升汤五剂，热退而愈。停数日又发热如故，思此症愈后不致再发，必是饮食不慎之故。细询之，方知山药两假白糖共食，则脾家邪复之，故又将服葛升汤三剂而愈。停五日又发，再四询云：惟饮粥，并未食他物。再询其将何物下粥，云：是门口所买盐老卜，不知是鱼鹵所浸，是以如此。又令服葛升汤三剂而愈。乃知瘧症条中言明饮食消息止之，而饮食又能发之也。

壬戌七月中，邓姓外孙全官忽发热，上午和下午甚有汗不解数日。后即服葛升汤五六剂即愈。其兄少蓉亦如此，发热，有汗不解，亦用葛升汤，因有微寒，加柴胡，数剂而愈。此即瘧症治法也。

孙女适王氏产后甫满月，入月杪忽发热，上午和下午甚，稍有汗不解，大便自溏，一日数次，背觉微寒，脉两手紧而数，此因内有伏暑，外受风寒，所以如此。用葛升汤加桂枝五分，赤芍一钱五分，炒黑荆芥穗一钱五分。三剂而脉静身凉，肚腹亦好。

余孙保安，八月杪亦患瘧症四五日矣。脉象洪数，亦用葛升汤，原方加赤芍，六剂，脉和身凉矣。初服呕去，第二日仍原方分三次服，即不呕矣。

陆外孙之子百六官七岁，于闰八月内忽大泻后变痢，或赤或白，脐中痛，日中二十余次，夜则十余次。药用苏梗、青皮、陈皮、通草、藿香、大腹皮、生熟砂仁、赤苓、泽泻、枳壳、花槟榔，再令刮背肾俞穴，在命门两旁、两大肠俞穴、背脊第十六椎下两旁各开一寸五分，两小肠俞穴在背脊十八椎下两旁各开一寸五分。盖因今年痢疾是疫症，故用痢疾治法。用前方二剂后减去小半，后将原方加煨葛根、升麻两剂，即截然而止。深秋伏邪晚发，初起热势起伏，不甚发扬，脉亦细数而沉，数日后即大热，亦当用葛升汤加赤芍药。如兼痢或泻者，兼用痢疾痧刮，针法亦效。

误服生鸦片烟并非真死说

自鸦片烟之流入内地，而于水火刀绳砒毒之外顿添一速死之途。且近日之烟实在为害不浅，其死于此者亦较诸物为尤众。殊不知此物但能迷人醉人，并不能死人也。夫烟之害，莫甚于广东。道光七八年间，有三水县人住在省城客店，因贫服生烟而死。店主不能收殓，专人赴三水告其亲属，及亲属赶到，店中死者已先一日活转。其死去三日四夜。又广东老件作云：凡吃烟死者，棺殓后倘因事开棺检验，从无平正仰卧之尸，非伏即侧。盖烟性既过，其人醒转则必翻腾求出，而棺盖已合，遂至真毙。故凡服烟乍死者，皆非真死也，岂不冤哉？现在广东新刊套板《洗冤录》，内明著救治之方。曰：轻者心中发躁，但用活鸭血或粪汁或酱油或凉水或明矾、雄黄研末灌之，无弗愈者。若服多，毒重身冷气绝，似乎已死，但支体柔软则脏腑经络之气仍是流通，实在未死，速将尸安放阴冷无太阳之地(一经日照即不可救)，撬开牙齿，用箸横在尸口，将金汁或凉水频频灌之。再以冷水在胸前摩擦，仍将头发解散浸在冷水盆内，自然得活。已目击救活数人，凡七日之内身不僵硬者，切勿棺殓云云。《洗冤录》为宫中验用之书，非随口传说者可比。倘肯广为传播，实今世活人第一要事。阅者试思未死活埋之苦，则传播之心不能已矣。又用净银花五钱，生军三钱，胆矾三钱，藜芦三钱，生甘草一西，水煎，蜂蜜五钱冲服。每能戒烟毒。

《医中一得》终